Ianalumab en enfermedad de Sjögren: ¿el primer biológico que funciona o una diferencia que no se siente?

Mariette X, Grader-Beck T, Finzel S, et al.; NEPTUNUS-1 and NEPTUNUS-2 Investigators. Ianalumab for the treatment of patients with Sjögren's disease. *N Engl J Med*. 2026;395:1585-99. doi:10.1056/NEJMoa2601088

Versión 1.0 · Revisado el 29 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Todavía no
Efecto pequeño en actividad sistémica y sin cambio en sequedad, fatiga ni dolor. Sin aprobación regulatoria publicada al cierre de esta edición.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Real, pero frágil
Dos ECA doble ciego replicados; el límite del IC toca el 0 y en NEPTUNUS-2 la significancia depende de cómo se imputan los datos faltantes.

CUIDADO AL INTERPRETAR
p <0.05 ≠ relevante
−1.0 a −1.3 puntos de ESSDAI frente a un cambio de −5 con placebo. La mejoría mínima importante individual es de 3 puntos.

En 30 segundos. Dos ensayos fase 3 doble ciego (NEPTUNUS-1, n=275; NEPTUNUS-2, n=504) en Sjögren activo (ESSDAI ≥5) compararon ianalumab, un anticuerpo anti-BAFF-R que además depleta linfocitos B, 300 mg SC mensual contra placebo durante 48 semanas. El ESSDAI bajó más con ianalumab: **diferencia −1.3 puntos** (IC 95 % −2.6 a 0.0; p=0.0496) y **−1.0** (−2.0 a 0.0; p=0.04). La dosis cada 3 meses no funcionó. El **placebo bajó −5.1 y −5.5 puntos**. No hubo diferencia en la proporción de respondedores ni en síntomas (ESSPRI, diario de síntomas). Más reacciones en el sitio de inyección; eventos graves similares. Los propios autores describen el efecto como **pequeño**.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Significancia estadística frente a relevancia clínica: cómo leer una diferencia de medias cuando el placebo mejora mucho; por qué un umbral de mejoría *individual* (3 puntos) no se puede aplicar tal cual a la diferencia *entre grupos*; qué significa que se "rompa la jerarquía" de desenlaces secundarios, y qué es un análisis de punto de quiebre (*tipping point*).

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Adultos con Sjögren (criterios ACR/EULAR 2016), diagnóstico en los últimos 7.5 años, **ESSDAI ≥5** en dominios sistémicos, flujo salival estimulado ≥0.05 mL/min y anti-Ro positivo (o biopsia positiva si anti-Ro negativo, ≤10 %). Edad media ~49 años; 92–95 % mujeres; ESSDAI basal ~12.
INTERVENCIÓN	Ianalumab 300 mg SC cada 4 semanas (en NEPTUNUS-2 también un brazo cada 3 meses). Premedicación con 50 mg de prednisona antes de la primera dosis.
COMPARADOR	Placebo. Se permitía tratamiento de base estable: hidroxicloroquina ≤400 mg/d, metotrexato ≤25 mg/sem, azatioprina ≤150 mg/d, prednisona ≤10 mg/d.
DESENLACE PRINCIPAL	Cambio en ESSDAI a la semana 48 (escala 0–123; en la práctica rara vez pasa de 40; >13 = actividad alta).

2 Diseño

TIPO	Dos ECA fase 3, multicéntricos, doble ciego, controlados con placebo, de 52 semanas. NEPTUNUS-1: 92 sitios en 18 países, 1:1. NEPTUNUS-2: 158 sitios en 26 países, 1:1:1. Estratificados por ESSDAI (≤13 o >13).
TAMAÑO	Calculado para detectar una diferencia de **2 puntos** de ESSDAI con poder de 82–83 %. Completaron tratamiento 83–89 %.
ANÁLISIS	ANCOVA ajustado por ESSDAI basal, estrato y región. Datos faltantes tras suspensión imputados con "copy increments in reference"; el resto, imputación múltiple. Desenlaces secundarios con prueba jerárquica.
FINANCIAMIENTO	Novartis Pharma diseñó los ensayos con el comité directivo, recolectó y analizó los datos.

3 Resultados

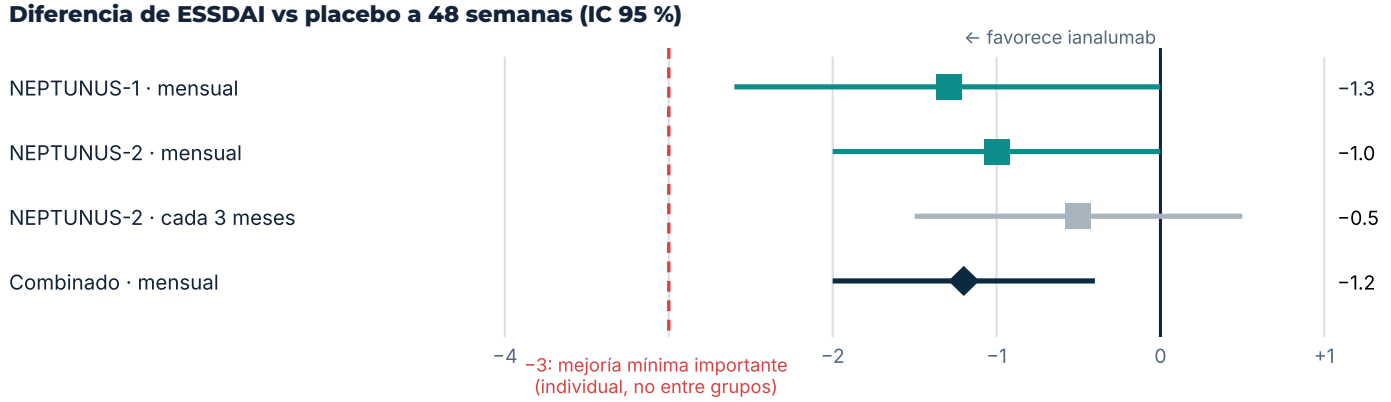
ESSDAI A 48 SEMANAS (CAMBIO MEDIO)	IANALUMAB	PLACEBO	DIFERENCIA (IC 95 %)	P
NEPTUNUS-1, mensual	−6.4	−5.1	**−1.3 (−2.6 a 0.0)**	0.0496
NEPTUNUS-2, mensual	−6.5	−5.5	**−1.0 (−2.0 a 0.0)**	0.04

NEPTUNUS-2, cada 3 meses	−6.0	−5.5	−0.5 (−1.5 a 0.5)	NS
Análisis combinado preespecificado (mensual)	—		−1.2 (−2.0 a −0.4)	—

SECUNDARIOS CLAVE (SIN VALOR DE P: JERARQUÍA ROTA)	NEPTUNUS-1 (IAN VS PBO)	NEPTUNUS-2 MENSUAL VS PBO
Respuesta ESSDAI (≥5 puntos)	57.4 % vs 48.3 %	59.8 % vs 55.2 % (cada 3 meses: 60.5 %)
ESSPRI (sequedad, dolor, fatiga; 0–10)	−1.73 vs −1.40 · dif −0.33 (−0.78 a 0.12)	−1.74 vs −1.50 · dif −0.23
Diario de síntomas SSSD (0–10)	−1.47 vs −1.08 · dif −0.38 (−0.81 a 0.05)	−1.58 vs −1.44 · dif −0.14
Flujo salival estimulado	+0.09 vs +0.08 mL/min	+0.15 vs +0.06 mL/min

SEGURIDAD (52 SEMANAS)	NEPTUNUS-1: IAN / PBO	NEPTUNUS-2: MENSUAL / C/3 M / PBO
Eventos adversos graves	3.6 % / 8.7 %	9.5 % / 7.8 % / 10.7 %
Infección grave	2.2 % / 0.7 %	3.0 % / 3.0 % / 4.7 %
Reacción local en sitio de inyección	27.0 % / 2.9 %	29.8 % / 23.4 % / 3.6 %
Reacción sistémica a la inyección	13.9 % / 0.7 %	14.9 % / 13.2 % / 8.3 %
IgM < límite inferior ≥12 semanas	11.4 % / 0.8 %	17.9 % / 8.8 % / 0.6 %
IgG < límite inferior ≥12 semanas	3.7 % / 0 %	0 % / 1.2 % / 0 %
Infecciones oportunistas · muertes	0 · 0 / 1 (placebo)	TB (mensual), candidiasis esofágica (c/3 m), CMV (pbo) · 0

Diferencia de ESSDAI vs placebo a 48 semanas (IC 95 %)



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos del texto del artículo; no reproduce figuras originales. La línea roja marca el umbral de mejoría mínima importante *en un paciente*; los autores aclaran que no existe un umbral validado para diferencias entre grupos.

4 Cómo leer estos resultados

- **Ambos grupos mejoraron mucho.** DATO DEL ARTÍCULO El placebo bajó −5.1 y −5.5 puntos; ianalumab, −6.4 y −6.5. Lo atribuible al fármaco es la diferencia: ~1 punto. INTERPRETACIÓN Si en consulta un paciente mejora 6 puntos, la mayor parte de esa mejoría la habría tenido igual: regresión a la media (se entra al estudio en un momento de actividad alta), expectativa y tratamiento de base.
- **El IC toca el cero.** −1.3 (−2.6 a 0.0) y −1.0 (−2.0 a 0.0): el efecto podría ser prácticamente nulo. El análisis de *punto de quiebre* de NEPTUNUS-2 perdió significancia si el placebo hubiera mejorado 2 puntos más en los datos faltantes; los autores lo describen como sensible a supuestos.
- **Un umbral individual no es un umbral entre grupos.** Una mejoría de ≥3 puntos de ESSDAI es significativa para un paciente. Una diferencia promedio de 1 punto puede significar que unos pocos responden mucho y la mayoría nada, o que todos mejoran un poco: con la media sola no se sabe. Por eso importa la **proporción de respondedores**, y ahí no hubo diferencia clara (57 % vs 48 % y 60 % vs 55 %).
- **La jerarquía rota.** Los secundarios se probaban en orden; como el primero no fue significativo, ninguno posterior puede declararse positivo. Los IC de ESSPRI y del diario de síntomas cruzan el cero: **no hubo efecto demostrado sobre lo que más le pesa al paciente** (sequedad, fatiga, dolor).
- **La dosis importa.** Cada 3 meses no funcionó: las concentraciones valle quedaron indetectables en ~60 % de las muestras. INTERPRETACIÓN Apoya que el efecto requiere bloqueo sostenido de BAFF-R, no solo depleción de linfocitos B.
- **Desbalances basales.** En NEPTUNUS-1 hubo más fenotipo de predominio glandular con ianalumab (43.8 % vs 31.2 %) y más tratamiento de base en placebo (73.2 % vs 69.3 %). Son diferencias moderadas que añaden incertidumbre a un efecto

pequeño.

CONCEPTO CLAVE · RESPUESTA PLACEBO EN SJÖGREN

INTERPRETACIÓN El ESSDAI exige actividad para entrar; con el tiempo muchos pacientes regresan hacia su nivel habitual aunque no reciban nada. Sumado a la expectativa de una enfermedad sin fármacos aprobados, esto produce mejorías grandes con placebo (−5 puntos) que "comen" el margen para demostrar un efecto. Por eso los resultados inconsistentes previos con rituximab o belimumab no necesariamente significan que la vía no importe, y un ensayo positivo con una diferencia de 1 punto tampoco significa un gran beneficio.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Aleatorización y cegamiento	Dos ECA doble ciego, replicados, estratificados; 83–89 % completaron.	Confirmado
Reproducibilidad	El resultado primario fue significativo en ambos ensayos y en el análisis combinado.	Confirmado
Magnitud del efecto	−1.0 a −1.3 puntos; el poder se calculó para 2 puntos. Los autores lo llaman "pequeño".	Reconocido por los autores
Datos faltantes	En NEPTUNUS-2, un cambio de −2 puntos en el placebo eliminaba la significancia.	Reconocido por los autores
Síntomas	Sin diferencia en ESSPRI ni en el diario de síntomas; jerarquía rota.	Confirmado
Seguridad a largo plazo	Solo 52 semanas; extensión en curso (NCT05985915). Hipogammaglobulinemia M frecuente.	Pendiente
Financiamiento	Novartis diseñó, recolectó y analizó los datos.	Dato del artículo
Aplicabilidad	Sjögren activo sistémico, de diagnóstico reciente (media ~3 años) y con glándula funcional; no aplica a enfermedad de predominio seco sin actividad sistémica. Población 56–65 % blanca, 5–13 % indígena americana.	Dato del artículo
Estado regulatorio	El artículo no lo menciona. La FDA le otorgó designación de terapia innovadora en enero de 2026; no encontramos aprobación publicada al cierre de esta edición.	Fuente externa

Pregunta de repaso: una paciente con Sjögren y ESSDAI de 14 por artritis y púrpura te pregunta por ianalumab porque "salió en el NEJM". ¿Qué le dices con base en este estudio?
Respuesta. Que en dos ensayos grandes redujo la actividad sistémica un poco más que el placebo (alrededor de 1 punto de ESSDAI sobre una mejoría de 5–6 que tuvieron ambos grupos), que no mejoró la sequedad, la fatiga ni el dolor, que produce reacciones en el sitio de inyección y baja de inmunoglobulinas en una minoría, y que aún no hay aprobación ni datos de seguridad más allá de un año. El manejo de su actividad articular y cutánea sigue las recomendaciones vigentes.

¿Qué aprendí de medicina?

- Primer anti-BAFF-R con depleción B en fase 3 positivo en Sjögren, con efecto pequeño.
- Funciona la dosis mensual; la trimestral no.
- No mejora sequedad, fatiga ni dolor.
- Vigilar reacciones de inyección e IgM baja.

¿Qué aprendí de investigación?

- p <0.05 con un IC que toca el 0 = efecto posiblemente mínimo.
- Umbral individual ≠ diferencia entre grupos.
- Jerarquía rota: los secundarios no se pueden declarar positivos.
- Análisis de punto de quiebre: qué tan frágil es el resultado.

6 Referencias

1. Mariette X, Grader-Beck T, Finzel S, et al. Ianalumab for the treatment of patients with Sjögren's disease. N Engl J Med. 2026;395:1585-99. doi:10.1056/NEJMoa2601088
2. Novartis. Novartis ianalumab receives FDA Breakthrough Therapy designation for Sjögren's disease. Comunicado, 16 de enero de 2026 (solo para el estado regulatorio).

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.